

Saksframlegg

Saksgang:

Møte	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	10. april 2025

Sak 036-2025

Sykehuset Innlandet HF – konseptfase for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt konseptrapport og ber om at den legges til grunn for det videre arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om finansiering av samlet forventet prosjektkostnad i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan finansieres fra og med 2026. Styret ber om at deler av finansieringen gis som et investeringstilskudd.
3. Styret ber om at intensjonsavtalene med universitetene ferdigstilles før oppstart av forprosjekt. Gjeldende retningslinjer for universitetsarealer i sykehusbyggprosjekter fra Prop. 1 S (2017-2018) legges til grunn. Omsøkt finansiering forutsetter investeringslån for 100% av kostnadsramme (P85-estimat) for universitetsarealene, og det forutsettes at universitetene betaler en kostnadsdekkende husleie.
4. Oppstart av forprosjekt forutsetter finansiering og styrets godkjenning. Økonomisk styringsmål og finansieringssammensetning fastsettes ved godkjenning av oppstart av forprosjektet.
5. Styret legger til grunn at ansvaret for finansieringen av rekkefølgekrav blir som beskrevet i brev fra Ringsaker kommune jf. styresak 033-2025, vedlegg 4, og at eventuelle rekkefølgekrav fra statlige myndigheter finansieres med investeringstilskudd. Styret skal holdes løpende orientert om eventuelle endringer.
6. Styret ber om at Sykehuset Innlandet HFs arbeid med omstilling og økonomisk forbedring i forkant av innflytting styrkes. Det skal gis en utvidet status for arbeidet i forbindelse med godkjenning av oppstart forprosjekt og ved investeringsbeslutning etter gjennomført forprosjekt.

7. Styret ber om at tiltak for å gjøre Mjøssykehuset til en foretrukket arbeidsplass prioriteres i det videre arbeidet.
8. Styret ber om at prosjektet planlegges med en gjennomføringsstrategi som reduserer risiko og legger til rette for kostnadseffektiv bygging ved gjenbruk av prosjekterte løsninger, standardisering og industrialisering.
9. Styret ber om at det videre arbeidet planlegges med relevant medvirkning fra ledere, ansatte og brukere ved Sykehuset Innlandet HF.

Hamar, 3. april 2025

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1 Hva saken gjelder

Arbeidet med å videreutvikle en ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF har vært omfattende og pågått over mange år. Målet med konseptfasen har vært å utvikle et konsept som ivaretar de prosjektutløsende behovene og målbildet til helseforetaket. Styret skal i tråd med gjeldende fullmaktstruktur for byggeinvesteringer godkjenne konseptfasen for prosjektet videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, og med det beslutte valgt konsept som grunnlag for videre arbeid i forprosjektfasen. Godkjenningen er definert som beslutningspunkt B3: Valg av konsept i henhold til *veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*.

Saken belyser særskilt de forhold som ble kommentert av styret i sak 033-2025 *Sykehuset Innlandet HF – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen*, og som må vies særlig oppmerksomhet i det videre arbeidet. Dette gjelder gevinstplaner og arbeidet med kuttlistor, rekruttering- og omstillingsrisiko, samt alternativ finansiering, herunder statlig tilskudd og alternative låne- og egenfinansieringsandeler.

Godkjent konseptfase er underlag for søknad til Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på finansiering over statsbudsjettet for 2026.

2 Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1. Tidligere behandling

Planene for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har vært under arbeid i flere år, med oppstart av konseptfase i 2021. Bakgrunn og prosjektutløsende behov for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF er forankret i vedtak fra tidligere foretaksmøter og styrebeslutninger.

Styret godkjente i sak 102-2022 *Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF* at Mjøssykehusalternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen, og at Mjøssykehuset planlegges på tomt «Moskogen» i Moelv.

Styret behandlet i møtet 14. mars 2025, sak 033-2025 *Sykehuset Innlandet HF – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen*. I orienteringssaken ble det redegjort for arbeidet med konseptfasen og endringer som har skjedd siden steg 1. I samme styresak framkommer de vedtak som tidligere er fattet av styret og foretaksmøtet fra og med sak i Helse Sør-Øst RHF 058-2021 *Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset innlandet HF*.

Styret fattet i sak 033-2025 følgende vedtak ifølge foreløpig protokoll:

1. Styret tar redegjørelsen for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF til orientering.
2. Styret ber om at det legges fram en sak til styremøtet 10. april 2025 om beslutning om lånesøknad. Følgende forhold skal belyses og drøftes:
 - Gevinstplaner og arbeidet med kuttlistor.
 - Alternativ finansiering, herunder statlig tilskudd og alternative låne- og egenfinansieringsandeler.

Vedtakspunkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtakspunkt 2 ble vedtatt mot tre stemmer (Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg).

«Stemmeforklaring fra Grimsgaard, Kronkvist og Sølvberg»

Det vises til styresak 102-2022. I konseptfasens del to har konseptet blitt ytterligere detaljert og utviklet. Investeringsestimater er nå økt med 4,6 milliarder kroner. Forutsetningene er vesentlig endret sammenholdt med vedtaket i sak 102-2022.

Samlet investeringsestimat i de to løsningene ikke veldig ulik, med oppgradering av øvrig bygningsmasse er kostnaden i null-alternativet i størrelsesorden 85 prosent av kostnadene for Mjøssykehus-løsningen. Det er imidlertid vesentlig forskjeller i estimerte gevinster. Gevinstanslaget for nullalternativet utgjør kun 6 prosent av estimerte gevinster i Mjøssykehusløsningen (30 versus 470 millioner). Null-alternativet synes ikke å være optimalisert, verken med hensyn til investeringsomfang eller gevinster.

Det er i saken anslått 171 og 174 millioner i investeringskostnader knyttet til foretaksmøtets vedtak om tilpasning av bygningsmasse for Elverum og Tynset. I drøftingsprotokollen vedlagt saken er det framstilt at samlet kostnad for løpende oppgradering og rehabilitering av anleggene på Elverum og Tynset er anslått til 2492 millioner. Disse medlemmene er usikre på om avsetningene på drøye 170 millioner for hvert av de to anleggene vil være i tråd med føringene gitt i foretaksmøtet. Disse medlemmene vurderer at realisering av foretaksmøtets krav bygger på en forutsetning om det vil bli stilt midler tilgjengelig i tråd med foretakets økonomiske langtidsplan til løpende rehabilitering og oppgradering. Disse medlemmene vurderer at det er høy risiko for at denne forutsetningen ikke vil la seg innfri.

Disse medlemmene er bekymret for det høye investeringsnivået i både Mjøssykehus- og nullalternativet. Anslaget for gevinster før og etter innflytting i Mjøssykehuset er høye, og forutsetter vesentlig bemanningsreduksjon i forhold til oppgavemengden. Disse medlemmene anser at det ikke er sannsynlig at dette vil la seg realisere uten vesentlig reduksjon i pasienttilbudet. Det vises til drøftingsinnspill i saken.

Disse medlemmene mener at null-alternativet ikke er tilstrekkelig godt utviklet, og at dette alternativet bør optimaliseres ytterligere for å få framstilt og detaljert et alternativ med vesentlig lavere samlede investeringskostnader og bedre utviklet gevinstanalyse.»

Sykehuset Innlandet HF behandlet i sitt styremøte 25. mars 2025 sak 033-2025
 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfasen steg 2. Styret i Sykehuset Innlandet HF
 fattet følgende vedtak, mot en stemme, ifølge foreløpig protokoll:

1. *Styret anbefaler at den framlagte Konseptrapport steg 2 – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet, legges til grunn for videre arbeid med forprosjekt.*
2. *Styret ber administrerende direktør oversende Sykehuset Innlandets anbefaling til Helse Sør-Øst RHF med mål om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån i henhold til gjeldende retningslinjer.*
3. *Styret vektlegger behovet for faglig og økonomisk bærekraft i de omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen skal igjennom og forventer særskilt oppmerksomhet på områdene beholde og rekruttere medarbeidere, økonomi og omstilling.*
4. *Styret forutsetter at prosjektet planlegges med en gjennomføringsstrategi som bidrar til god styring og risikoreduksjon, og at det utarbeides gevinstplaner og kuttlistor for å sikre nødvendig kostnadstilpasning i gjennomføringsfasen.*
5. *Styret forutsetter at det også i det videre arbeidet fram mot ny struktur blir lagt til rette for medvirkning fra de ansattes organisasjoner, relevante fagmiljø, brukere og andre interessenter.*

Vedtaket ble gjort med følgende protokolltilførsel til vedtakspunkt 3 og 4 fra ansattes representanter Tone Kristine Amundgaard og Ann Charlène Letnes:

«Fra et ansattperspektiv ønskes følgende merknad til vedtakspunkt 3 og 4 om risiko i faglig og økonomisk bærekraft og bekymring for kuttliste for kostnadsreduksjon. Ansvarlige videre i denne saken må sørge for økonomisk tilskudd for å redusere risiko. Det må også legges til rette for infrastruktur og transport.

Forutsetningene for effektivisering og kostnadstilpasning på om lag 900 millioner fra dagens SIHF, vil representere en betydelig endring av dagens pasienttilbud på veien mot og inn i nytt bygg og kan påvirke ansattes arbeidsbelastning, arbeidsforhold, og kommunehelsetjenesten. Det foreligger en risiko for å beholde kompetanse i dette. I tillegg skal resterende bygningsmasse på Tynset og Elverum som ikke omfattes i lånesøknaden, finansieres i ØLP sammen med oppgradering av Lillehammer. Tilfluktsrom og beredskapslager må også inn dersom dette kommer som et krav.

Det ligger et stort ansvar på foretaket i å være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde og rekruttere personell innen alle deler av pasientbehandlingen, samt viktige støttefunksjoner og i omstillingsprosesser i en tid mot økende helsepersonellmangel. Det må gjøres kraftig innsats i lønn og personalgoder. Livsfasetilpasninger er avgjørende. Unngå tidstyver i arbeidshverdagen som kø, manglende parkering eller vente på kollektivtransport er viktig. Arealbesparelser ved lange enkorridor- løsning for sengeposter i somatikk og tre etg i psykisk helsevern vil kreve ekstra ressurser.

Den største bekymringen nå er kuttliste som grunnlag for kostnadsreduksjon. Det kan ikke gå på bekostning av arbeidsforholdene i et nytt bygg, attraktiviteten for helsepersonell og tilgangen på kompetanse for pasientene.

Viser forøvrig til TV20 drøftingsprotokoll 14.03.25.»

Stemmeforklaring fra styremedlem Per H. Christensen:

«Kan ikke anbefale at lånesøknad blir sendt med det saks- og tallgrunnlaget som legges til grunn i sak 033-2025. Prosjektet fremstår som umodent og det er flere usikkerhetsmomenter, blant annet kjent usikkerhet vedrørende infrastruktur og, nå nylig, også tilkommet ubesvarte spørsmål vedrørende behov for kostnadskrevende tilfluktsrom.

Utfra tilgjengelige dokumenter er det vanskelig å forstå at prosjektet kan være bærekraftig på foretaksnivå. Har foretaket noen plan hvis økonomien i prosjektet ikke holder?

Den økonomiske risikoen i prosjektet er høy. Det hefter usikkerhet både til besparelser i forkant, byggekostnader, og ikke minst til gevinstrealisering etter innflytning. Det knytter seg stor bekymring til kapitalbelastningen som foretaket vil få i årene etter innflytning. SI vil være det helseforetaket i Helse Sør Øst med dårligst økonomisk forutsetning til å klare dette grunnet svak befolkningsvekst og risiko for pasientlekkasje fra sør-fylke.

Videre må man også påpeke KSK sine anmerkninger om usikkerheten knyttet til investeringskostnadene for Elverum og Tynset.

I konseptfase 1 ble det påpekt at Mjøssykehuset var det alternativet som har svakest rekrutteringsevne. Med de besparelser og endringer som må gjennomføres er risikoen stor for mangel på helsepersonell i Mjøssykehuset. Dette også sett i lys av dagens rekrutteringssituasjon og forventet stor mangel på sykepleiere i tiden fremover. SI er allerede i dag ikke spesielt konkurransedyktig på lønn i forhold til andre helseforetak, private aktører eller kommuner. Mangel på helsepersonell og besparelser vil høyst sannsynlig gå på bekostning av det faglige tilbudet til pasienter.

Man kan også registrere at null pluss alternativet ikke er gitt en særskilt fremstilling i rapporten, videre må det påpekes at man aldri har gjort en optimal utredning av 0+, dvs en sykehusstruktur med 2 somatiske akuttisykehus og 2 elektive. Det fremstår videre som merkelig at 0+ alternativet kun gir en besparelse på 6 % i forhold til Mjøssykehuset alternativet med sine 3 somatiske akuttenheter. Videre foreligger det ingen forklaring på at 0+ må være 145 000m² større enn Mjøssykehuset selv om man beholder de to psykiatriske sykehusene.»

2.2. Kort om konseptrapporten og arbeidet i konseptfasen

Som orientert om i styresak 033-2025 Sykehuset Innlandet HF - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen, har konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF omfattet utredninger av et Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv, elektiv ortopedi og rehabilitering, akutt indremedisin, fødestue og barselavdeling ved sykehuset i Elverum, og en styrking av tilbudet ved sykehuset på Tynset. En luftambulansbase med døgnskuttinuerlig vaktfunksjon i nærheten av Elverum er også inkludert i utredningen.

Målet har vært å finne det konseptet som best støtter opp under målbildet for helseforetaket, jf. styresak 005-2019 Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF innenfor de rammer som foretaksmøtet senere har vedtatt.

For nærmere detaljer om konseptfaserapporten henvises det til styresak 033-2025 Sykehuset Innlandet HF - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen, samt uttrykte vedlegg til denne saken.

2.2.1. Mjøssykehuset

For å ivareta besluttet virksomhetsinnhold og framskrevet kapasitet, har prosjektet vurdert ulike løsningsforslag for Mjøssykehuset. Med innspill fra uavhengig tredjeparts gjennomgang (second opinion) og vurderinger med bistand fra utviklingsprogrammet *Bedre megaprojekter*, er konseptet bearbeidet og videreutviklet i flere omganger. Bearbeidingen som ble gjort siden våren 2024, har resultert i en reduksjon i investeringsestimater med omtrent 1,9 milliarder kroner. Ledere, tillitsvalgte og verneombud ved Sykehuset Innlandet HF har vært trukket inn i arbeidet. Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet HF har også vært en aktiv bidragsyter. I tillegg har konseptfasen inneholdt tilleggsutredninger for å vurdere risiko knyttet til rekruttering og om trinnvis utbygging kan benyttes som risikoreduserende tiltak.

Det anbefalte konseptet inneholder et stort behandlingsbygg, sengebygg med ensengsrom, bygg for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, bygg for strålebehandling, energisentral og parkering. Konseptet ivaretar også helikopterlandingsplass for både ambulansehelikopter og redningshelikopter (SAR Queen, AW 101). Det er i konseptutviklingen lagt stor vekt på samarbeid og integrasjon mellom fagområder, møteplasser og kunnskapsdeling, viktigheten av å beholde og rekruttere personell, samt arbeidsflyt og effektiv logistikk og drift. Det er i tillegg utarbeidet et konsept for ikke-byggnær IKT som beskriver hvordan de regionale IKT-konseptene skal tas i bruk for å understøtte effektiv og moderne drift av sykehuset. For å realisere målbildet har helseforetaket satt seg høye ambisjoner innen digital, desentralisert samhandling og hjemmesykehus med digitale løsninger.

Samlet sett er Mjøssykehuset planlagt med et netto arealbehov på 56 537 kvadratmeter. I dette inngår nettoareal til utdanningsinstitusjonene Universitetet i Innlandet, Universitetet i Oslo og NTNU på 1 506 kvadratmeter og Sykehusapotekene HF på 827 kvadratmeter. Det anbefalte bygningskonseptet gir et totalt bruttoareal på 134 461 kvadratmeter.

Som del av konseptfasen er det gjennomført en økonomisk usikkerhetsanalyse. For Mjøssykehuset viser analysen et forventet tillegg på 13,6 prosent av basiskalkylen. Det forventede tillegget utgjør 1 966 millioner kroner. Investeringsestimater med det forventede tillegget er 18 457 millioner kroner (P50-estimat, prisenivå september 2024) eksklusive tomtekostnader. Kostnaden inkluderer ikke-byggnær IKT (722 millioner kroner) og areal til universitetene (427 millioner kroner).

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF er det gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptfasen (KSK). KSK oppsummerer med at konseptfasen er gjennomført i tråd med gjeldende krav og føringer og kommer med anbefalinger for videre arbeid.

I sak 120-2024 *Oppdatert behovsvurdering for framtidig kapasitet innen stråleterapi i Helse Sør-Øst*, ble styret orientert om observerte endringer i faktisk bruk av strålebehandling de siste årene. Det registreres at utviklingen de siste årene har vist en redusert bruk av stråleterapi i regionen i forhold til insidensutviklingen av kreft. Oppdaterte framskrivninger fra mars 2025 viser likevel et samlet behov for økt strålebehandlingskapasitet i årene framover, blant annet som følge av utviklingen i demografi. I lys av oppdatert informasjon vurderes det at foreliggende estimat for nytt strålesenter ved Mjøssykehuset ligger noe lavt i forhold til kapasitetsbehovet, og det anbefales at strålesenteret etableres med tre strålebunkere istedenfor to, men at senteret i første omgang utstyres med to linaker. Dette

tilsvarer kapasiteten ved strålesenteret på Gjøvik per i dag. Nettoarealet anbefales økt med i underkant av 300 kvadratmeter og bruttoarealet med i underkant av 800 kvadratmeter. Forventet prosjektkostnad økes med 70 millioner kroner (P50-estimat) for å kompensere for dette. Se avsnitt 2.2.5 *Investeringskalkyle*.

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF vurderer at det beskrevne konseptet ivaretar Sykehuset Innlandet HF sine mål med prosjektet, og at konseptet gir en kapasitet i tråd med framskrivingen. Brukerutvalgene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF har uttalt sin klare støtte til framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

2.2.2. Sykehuset i Elverum

Virksomheten ved sykehuset i Elverum planlegges i tråd med vedtaket i foretaksmøtet 7. mars 2024. Utgangspunktet for arbeidet i konseptfasen har vært nødvendig tilpasning og rehabilitering av bygningsmassen for å ivareta de kliniske behovene som følger av etablering av et bevegelsessenter med fysikalsk medisin og rehabilitering. Basert på dette er det vurdert ulike løsninger for rokader og ombygginger av eksisterende arealer.

Det anbefalte konseptet er basert på en rokadeplan der hovedgrepet er å legge fysikalsk medisin og rehabilitering (døgnfunksjonen) til plan 5, der pasienthotellet ligger i dag. Endret innhold i sykehuset åpner for andre rokader, noe som frigjør plass for fysikalsk medisinsk poliklinikk på plan 2 og opptrening på plan 0.

Videre er det vurdert løsninger som legger til rette for at aktiviteten innenfor psykisk helsevern for barn og unge og det fleksible aktivt oppsøkende behandlingsteamet (FACT), som i dag har leide arealer utenfor bygningsmassen, samlokaliseres med somatisk virksomhet ved sykehuset i Elverum. I tillegg er det vurdert om det er rom for å flytte avdeling for behandlingshjelpemidler og kontorarbeidsplassene, som i dag er lokalisert i et eldre bygg ("Vaskeribygget"), inn i sykehusbygget.

Foretaksmøtet har vist til at det skal legges til rette for samspill med Forsvarets aktivitet og det medisinske miljøet ved sykehuset i Elverum. Sykehuset Innlandet HF inngikk 29. november 2023 en samarbeidsavtale med Sanitetskompani 3, som til daglig opererer på Rena og trener med Telemark Bataljon. Formålet med samarbeidsavtalen er primært økt klinisk erfaring og pasienthåndtering for sanitetskompaniet, . Gjennom samarbeidet vil utvekslingen av ressurser også tilføre helseforetaket kompetanse som Forsvaret kan tilby. Ved etablering av Mjøssykehuset og ny luftambulansebase på Elverum vil både det akuttmedisinske og prehospitale tilbudet for Forsvaret i området Rena/Elverum bli styrket. Det vil bli lagt vekt på å utvikle etablerte strukturer og samarbeidsarenaer med Forsvaret i det videre arbeidet med ny sykehusstruktur.

Den gjennomførte usikkerhetsanalysen for det planlagte arbeidet ved sykehuset i Elverum viser et forventet tillegg på 13 prosent, som tilsvarer 20 millioner kroner, og som gir et investeringsestimat på 171 millioner kroner (P50-estimat, prisnivå september 2024).

2.2.3. Sykehuset på Tynset

I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 7. mars 2024 har konseptfasen inkludert en utredning av hvordan en styrking av tilbudet ved sykehuset på Tynset kan ivaretas, og hvilken nødvendig rehabilitering som må til for å ivareta bygningsmessige behov slik at styrking av tilbudet ved sykehuset muliggjøres også på lengre sikt.

I det anbefalte konseptet er det beskrevet investeringer for å styrke tilbudet på Tynset gjennom økning av elektivt volum i generell kirurgi, samtidig som volumet i elektiv ortopedi beholdes. Det forutsettes et tett faglig samarbeid mellom sykehuset på Tynset og de øvrige sykehusene i Sykehuset Innlandet HF. Det er videre beskrevet hva som kreves av oppgradering og modernisering av sykehusbygget for å oppnå god pasientflyt, logistikk og effektivitet. Det er vurdert at det anbefalte konseptet gir en kapasitet i tråd med framskrivingen.

Det er gjennomført egen økonomisk usikkerhetsanalyse for de planlagte arbeidene ved sykehuset på Tynset. Analysen viser et forventet tillegg på 17 prosent som tilsvarer 25 millioner kroner. Totalt er investeringsestimatet for Tynset 174 millioner kroner (P50-estimat, prisenivå september 2024).

2.2.4. Luftambulansebase på Elverum

Som del av konseptfasen er det utarbeidet et konsept for luftambulansebase med døgnkontinuerlig vaktfunksjon ved Elverum, vest for Glomma og i nærheten av riksvei 3. Dette vil styrke tilbudet av prehospitale tjenester i Innlandet og sørge for bedret luftambulansedekning i Østerdalen.

Det planlegges å etablere et basebygg med hangar og landingsplass. Det skal tilrettelegges for legebil og mulighet for å lande redningshelikopter (SAR Queen, AW101) for å øke samlet beredskap i området. Det er startet dialog om opsjonsavtale for tomt.

Det er gjennomført egen økonomisk usikkerhetsanalyse for arbeidet. Totalt investeringsestimat er 144 millioner kroner (P50-estimat, prisenivå september 2024) eksklusive tomteerverv.

2.2.5. Investeringskalkyle

Tabellen nedenfor oppsummerer investeringsestimatene, som til sammen beløper seg til 19 016 millioner kroner (P50-estimat, prisenivå september 2024).

Byggekostnad (MNOK)	Mjøssykehuset	Tillegg stråleterapi	Luftambulanse-base Elverum	Iverum sykehus	Tynset sykehus	Totalt
Basiskostnad eks. funksjonsutstyr	14 454	62	126	151	149	14 941
Forventet tillegg	1 966	8	18	20	25	2 038
- i % av basiskostnad	13,6 %	13,6 %	14,3 %	13,2 %	16,8 %	13,6 %
Prosjektkostnad P50	16 420	70	144	171	174	16 979
Usikkerhetsavsetning	3 682	16	30	37	42	3 807
- i % av P50	22,4 %	22,4 %	20,8 %	21,6 %	24,1 %	22,4 %
P85-estimat	20 102	86	174	208	216	20 786
Funksjonsutstyr	1 314	-	-	-	-	1 314
Ikke-byggnaer IKT (O-IKT)	722	-	-	-	-	722
P50 inkl. funksjonsutstyr og O-IKT	18 457	70	144	171	174	19 016

Tabell 1 Investeringskalkyle

Totalt investeringsestimat (P50-estimat) er 70 millioner kroner høyere enn hva som framgikk av styresak 033-2025 *Sykehuset Innlandet HF – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen*. Dette er en følge av oppdatert informasjon om kapasitet innen stråleterapi.

Det vil tilkomme kostnader for tomteerverv for luftambulansebase i Elverum og eventuelle tilstøtende tomter til Mjøssykehuset. Potensielle kostnader for tomteerverv kommer i tillegg til den totale investeringskostnaden. Det estimeres en øvre ramme for totalt tomteerverv på 30 millioner kroner.

Analysene av økonomisk bæreevne i konseptrapporten er gjort uten investeringene som følger av oppdatert informasjon om kapasitet innen stråleterapi og øvre ramme for totalt tomteerverv. Dette medfører ingen vesentlige endringer til analysene, og Sykehuset Innlandet HF vil fortsatt vise økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå under øvrige forutsetninger for prosjektoppdattert økonomisk langtidsplan.

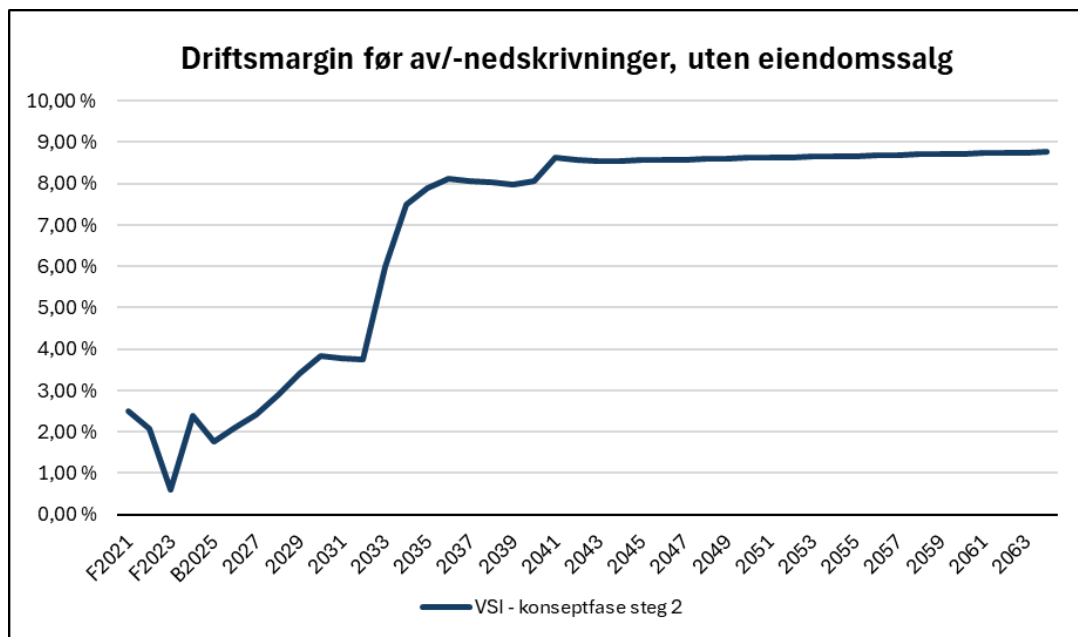
2.3. Gevinstplaner

Sykehuset Innlandet HF står overfor en betydelig økonomisk omstilling og krav til gevinstrealisering for å kunne betjene økte kapitalkostnader fra investeringene i videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

I styresak 025-2025 *Økonomisk bæreevne i perioden 2026-2032* ved Sykehuset Innlandet HF har helseforetaket dokumentert en plan for å realisere nødvendige kostnadstilpasninger i forkant av at ny sykehusstruktur tas i bruk. Denne planen vil bli konkretisert med tiltak for større omstillinger innen utgangen av 2025.

I styresak 016-2025 *Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om arbeider i konseptfase steg 2* har helseforetaket dokumentert vurderinger av driftsøkonomien i framtidig sykehusstruktur. I dette ligger utredningen av driftsgevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter som følge av investeringstiltakene og ny sykehusstruktur.

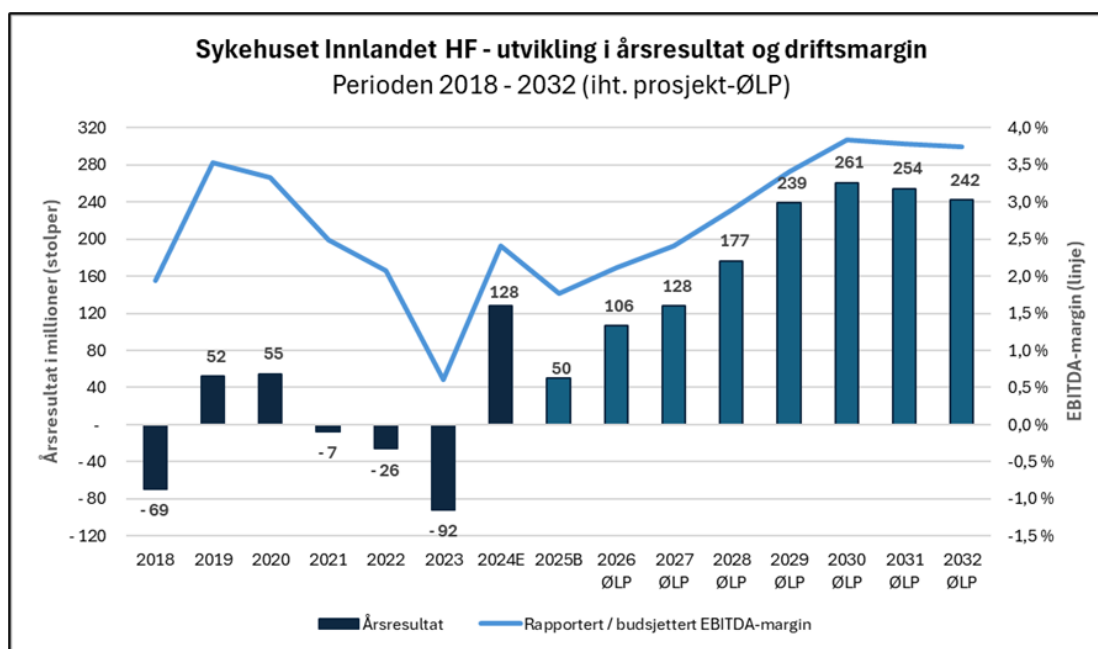
Basert på forutsetningene fra disse styresakene legger helseforetaket til grunn en økning i driftsmargin før av- og nedskrivninger (EBITDA-margin) fra 1,8 prosent i budsjett 2025 til 3,7 prosent i 2032, som er året før ny sykehusstruktur kan tas i bruk. Videre medfører driftsgevinstene og de øvrige driftsøkonomiske effektene en økning i EBITDA-margin til om lag åtte prosent fra full realisasjon av driftsgevinster i 2036. Økning til en forutsatt langsiktig EBITDA-margin på om lag 8,7 prosent fra 2041 er i hovedsak knyttet til bortfall av tjenestepris for ikke-bygg nær IKT. I praksis vil det langsiktige nivået på helseforetakets EBITDA-margin tilpasses de faktiske kapitalkostnadene knyttet til ny sykehusstruktur og nødvendige reinvesteringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr.



Figur 1 Forutsatt utvikling i driftsmargin (før av- og nedskrivninger)

For å skape framtidig økonomisk bæreevne er det nødvendig med omfattende kostnadstilpasninger i perioden 2026–2032. Sykehuset Innlandet HFs styresak 025-2025 *Økonomisk bæreevne i perioden 2026-2032* gir en foreløpig beskrivelse av tiltakene som skal sikre bærekraftig drift. Arbeidet vil videreføres og konkretiseres gjennom den ordinære prosessen med økonomisk langtidsplanlegging og budsjettarbeid. Tiltakene er basert på etablerte tiltaksområder virksomhetsstrategien for 2025–2028, økonomisk langtidsplan, og årlige budsjetter. Planen vil bli konkretisert med tiltak innen større omstillinger innen utgangen av 2025, før vedtak om igangsetting av forprosjekt.

Sykehuset Innlandet HF har historisk sett hatt gode økonomiske resultater, men de siste årene har utviklingen vært negativ. I 2024 ble det budsjettet med et positivt årsresultat på 30 millioner kroner som helseforetaket har realisert. I tillegg medførte blant annet nysaldering av statsbudsjettet for 2024 at det foreløpige årsresultatet for 2024 viser et positivt resultat på 128 millioner kroner. For 2025 er det budsjettet et årsresultat på 50 millioner kroner, med en gradvis økning til 261 millioner kroner i 2030 for å skape en mer bærekraftig økonomi og for å legge til rette for nødvendige investeringer i perioden fram til ny sykehusstruktur tas i bruk.



Figur 2 Historisk og forutsatt utvikling i årsresultat og driftsmargin (før avskrivninger og renter) for perioden 2018 – 2032 for Sykehuset Innlandet HF

Den framskrevne resultatutviklingen forutsetter årlige kostnadstilpasninger som utvikler seg til 368 millioner kroner forbedret driftsresultat i året 2032 sammenlignet med 2025. I tillegg forutsettes en reduksjon i kostnad for ekstern innleie på 40 millioner kroner i året 2028 og utover, også sammenlignet med 2025.

Sykehuset Innlandet HF - akkumulert endring i driftsresultat eks. avskrivninger (EBITDA) fra budsjett 2025

NOK i millioner	F2024	B2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EBITDA B2025			200	200	200	200	200	200	200
Akkumulert økning driftsinntekter			41	138	236	342	460	570	682
Akk. økning driftskostnader iht. aktivitetsvekst			-66	-139	-206	-289	-379	-476	-574
Resultateffekt av inntekts- og aktivitetsforutsetninger			-26	-1	30	52	81	94	108
Akk. økning tjenestepreis IKT			-53	-93	-140	-186	-186	-186	-186
Akk. reduksjon - ekstern innleie			20	30	40	40	40	40	40
Akk. reduksjon - kostnadstilpasninger			105	170	235	310	340	355	368
EBITDA før prosjekteffekter	262	200	246	307	365	416	475	503	530
Akk. økning pukkelkostnader og andre prosjekteffekter	-	-	-5	-30	-30	-17	-22	-52	-79
Total EBITDA	262	200	241	277	335	399	453	450	451
<i>EBITDA-margin før prosjekteffekter</i>	2,4 %	1,8 %	2,2 %	2,7 %	3,2 %	3,6 %	4,0 %	4,2 %	4,4 %
<i>Total EBITDA-margin</i>	2,4 %	1,8 %	2,1 %	2,4 %	2,9 %	3,4 %	3,8 %	3,8 %	3,7 %

Tabell 2 Forutsatt akkumulert endring i EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) og kostnadstilpasninger for årene 2026-2032 fra budsjett 2025.

For å håndtere de økonomiske utfordringene bygger helseforetaket planen for kostnadstilpasninger på tre hovedområder: *god drift, fokusområder og større omstillinger*.

Innenfor *god drift* ligger tiltak for effektiv ressursstyring, digitalisering og bedre bemanningsplanlegging for å redusere kostnader og forbedre driften.

Fokusområder omhandler tiltak for å redusere utgifter til høykostmedisiner, pasientreiser og private avtaleleverandører samt optimalisering av behandlingsnivå og pasientkontroller.

Større omstillinger omfatter sammenslåing av avdelinger, endring av opptaksområder innad i helseforetaket og vurdering av tjenestetilbud for å sikre en fremtidsrettet organisering og opprettholde økonomisk bæreevne.

Sykehuset Innlandet HF har lagt til grunn realisering av 50 prosent av de estimerte effektene av tiltakene innen *god drift* og *fokusområder*. Tiltak innenfor disse områdene forventes å gi nødvendig kostnadstilpasning i årene 2026 og 2027. Fra 2028 forventes en økende del av kostnadstilpasningen å komme fra strukturelle endringer/større omstillinger. Sykehuset Innlandet HF skal innen utgangen av 2025 utarbeide en plan for samling av fag og funksjoner. Arbeidet med plan for større omstillinger krever god involvering av fagråd, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste, og er derfor ikke ferdigstilt som en del av utredningen i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet.

Helseforetakets tiltak for å redusere kostnadene fram til ny sykehusstruktur tas i bruk, inkluderer virkninger av regionale kliniske løsninger. Realisering av disse gevinstene vil kreve en forsterket gevinstoppfølging, både regionalt og ved helseforetaket, og stiller krav til endringsledelse.

Sykehuset Innlandet HF har forutsatt å realisere en vesentlig andel av kostnadstilpasninger i 2026 og 2027. Ved en framtidig beslutning om prosjektgjennomføring (B4-beslutning), tentativt medio 2027, vil det dermed foreligge ny informasjon som gir Helse Sør-Øst RHF grunnlag for å vurdere helseforetakets evne til å realisere den forutsatte bedringen i driftsmargin.

Helse Sør-Øst RHF vil be Sykehuset Innlandet HF om jevnlig rapportering på status og utvikling for kostnadstilpasningene.

2.3.1. Driftsgevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter fra investeringstiltakene

I tråd med *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* (Sykehusbygg, 2024) har Sykehuset Innlandet HF utarbeidet en gevinstoversikt, spesifisert på hensiktsmessig nivå, som del av utredningene i konseptfasens steg 2. Ekstern kvalitetssikrer vurderer at «*gevinstene er synliggjort på nivå som tilfredsstiller kravene veilederen stiller til en konseptfaserapport*». I forprosjektet økes kravene til dokumentasjon av driftsgevinster til å omfatte en komplett gevinstrealiseringsplan med nullpunktsmålinger og fordeling av internt ansvar for videre oppfølging. Deretter er etablert praksis at helseforetaket oppdaterer gevinstrealiseringsplanen årlig som del av ordinær prosess med økonomisk langtidsplan.

Utredningen av driftsøkonomiske effekter av alternativene er gjennomført av Sykehuset Innlandet HF, og dokumentert i vedlegg til helseforetakets styresak 016-2025 *Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om arbeider i konseptfase steg 2*.

Sykehuset Innlandet HF forutsetter kjernedriftsgevinster på 470 millioner kroner per år fra tidspunkt for forutsatt fullt gevinstuttak i 2036. I tillegg kommer kostnadsdekkende husleie fra universitetene og Luftambulansetjenesten HF samt parkeringsinntekter, beregnet til 64

millioner kroner per år fra 2033. Netto driftsgevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter inkluderer også kostnader for mottaksprosjekt og organisasjonsutvikling på totalt 413 millioner kroner i perioden 2026-2033, tjenestepreis til Sykehuspartner HF for ikke-bygg nær IKT (O-IKT) for perioden 2033-2040 og estimerte årlige driftsgevinster på Tynset sykehus på fem millioner kroner.

NOK I millioner	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041->
Netto driftsgevinster																
Klinisk personell somatikk				15	30	30	30	120	181	202	215	215	215	215	215	215
Klinisk personell psyk/TSB								49	81	93	100	100	100	100	100	100
Medisinsk service- og støttefunksjoner								24	41	47	50	50	50	50	50	50
Prehospitaltjenester og pasientreiser								-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
FDV								25	25	25	25	25	25	25	25	25
Øvrige service- og støttefunksjoner								51	85	98	105	105	105	105	105	105
Andre driftseffekter								10	10	10	10	10	10	10	10	10
SUM KJERNEDRIFTSGEVINSTER	0	0	0	15	30	30	30	245	388	439	470	470	470	470	470	470
Øvrige driftsøkonomiske effekter																
Mottaksprosjekt	-5	-23	-23	-23	-41	-71	-98	-38								
Tjenestepreis for ikke-bygg nær IKT (O-IKT)								-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
OU-kostnader	-8	-8	-15	-15	-15	-15	-15									
Parkeringsinntekter								35	35	35	35	35	35	35	35	35
Husleie universitet								22	22	22	22	22	22	22	22	22
SUM ØVRIGE	-13	-31	-38	-38	-56	-86	-113	-71	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	57
SUM MJØSSYKEHUSET	-13	-31	-38	-23	-26	-56	-83	174	355	406	437	437	437	437	437	527
Driftsgevinster Tynset								5	5	5	5	5	5	5	5	5
Husleie luftambulansbase								6	6	6	6	6	6	6	6	6
SUM VIDEREUTVIKLING SYKEHUSET INNLANDET	-13	-31	-38	-23	-26	-56	-83	185	366	418	448	448	448	448	448	539

Tabell 3 Estimerte driftsgevinster og øvrige driftsøkonomiske effekter som følge av investeringsprosjektet

Driftsgevinstene for klinisk personell somatikk drives primært av reduksjon i parallell beredskapskapasitet, særlig på kveld/natt og i helger, samt samling av døgnenheter. Videre legger nybygg og forbedrede bygningsmessige løsninger til rette for mer effektive pasientforløp, styrket tverrfaglig samarbeid og mer hensiktsmessig organisering av vaktordninger. Teknologiske løsninger, inkludert sensorteknologi og automatisering, bidrar også til mer effektiv bruk av personalressurser. Totalt er endringene vurdert å gi en årlig driftsgevinst på om lag 215 millioner kroner.

For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling innebærer Mjøssykehuset en samling av sykehusbaserte funksjoner, som gir redusert behov for parallelle vaktlinjer og en mer helhetlig drift. Nærhet til somatiske tjenester gir bedre samhandling og raskere avklaringer, mens moderne lokaler legger til rette for mer effektive arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av ressurser. Atriumløsninger og skjermingsrom bidrar til økt pasientsikkerhet og reduserer behovet for ekstra personell. Totalt vurderes disse endringene å gi en årlig driftsgevinst på om lag 100 millioner kroner.

Innenfor medisinske service- og støttefunksjoner er det estimert driftsøkonomiske effekter for områdene radiologi, medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin samt medisinsktekniske avdelinger. Samling av funksjoner gir redusert totalbemanning på dagtid, reduksjon i vaktbemanning og bedre utnyttelse av medisinskteknisk utstyr. Netto driftsgevinster for området utgjør totalt om lag 50 millioner kroner.

Mjøssykehuset innebærer også en samling av merkantile tjenester, redusert behov for postkjøkken og en mer effektiv organisering av forsyning, portører og transport. Dette er forutsatt å gi en årlig gevinst på om lag 105 millioner kroner innen øvrige service- og støttefunksjoner.

For prehospitaltjenester og pasientreiser er det beregnet en netto økning i kostnader på om lag 35 millioner kroner for Mjøssykehuset, grunnet lenger reiseavstand for enkelte pasientgrupper.

Kostnadene knyttet til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) viser en positiv effekt for Mjøssykehuset, da prosjektet innebærer en reduksjon i totalarealet i bygningsmasse sammenlignet med dagens struktur. Det er imidlertid forutsatt en noe høyere kvadratmeterpris for FDV i nybygg, slik at den samlede nettoeffekten tilsier en kostnadsbesparelse på om lag 25 millioner kroner årlig. Energisentralen har medført et lavere energiforbruk per kvadratmeter sammenlignet med konseptfasens steg 1.

Sykehuset Innlandet HF hadde i 2024 fire prosentpoeng høyere andel variabel lønn sammenlignet med andre foretak i Helse Sør-Øst innen somatikk. For klinisk personell innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hadde helseforetaket 18 prosent høyere netto årsverk per innbygger, behovsjustert, sammenlignet med det regionale gjennomsnittet for 2024 (eksklusive Oslo universitetssykehus HF). Dette underbygger potensialet for kostnadstilpasninger ved helseforetaket og for driftsgevinstene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Driftsgevinstene som følge av færre parallelle vaktlinjer innen somatikk er basert på en kartlegging av vaktordninger ved andre helseforetak i regionen som har lignende struktur som det videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF innebærer. Helseforetakene som ble kartlagt var Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Østfold HF.

Driftsgevinster for sengeposter somatikk underbygges av en sammenligning mot Akershus universitetssykehus HF, som har sengeposter på samme størrelse som planlegges for Mjøssykehuset.

Helse Sør-Øst RHF vurderer at forutsetningene for utvalgte, større gevinstområder er underbygget med relevante sammenligninger mot driften ved andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet HF planlegger videre med en utvikling i driftsmargin fram til Mjøssykehuset tas i bruk som ligger om lag ett prosentpoeng lavere enn Vestre Viken HFs realiserte driftsmargin for 2024. Samlet vurderes likevel utviklingen i driftsmargin, inkludert effekter fra driftsgevinster, ved Sykehuset Innlandet HF som krevende for helseforetaket å realisere.

2.3.2. Oppdatert sammenligning med null-pluss alternativet

I konseptfasens steg 1 ble det utført en likeverdig utredning av to alternativer for å videreutvikle et godt pasienttilbud i Innlandet. I utredningen ble Mjøssykehus-alternativet sammenlignet med et null-pluss alternativ. Null-pluss alternativet innebar å bygge et erstatningssykehus på Hamar, en forbedret funksjonsfordeling mellom sykehusene på Elverum og Hamar og en samlokalisering av somatikk med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i dette området. Utredningen ble dokumentert i styresak 102-2022 *Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF*.

I steg 2 av konseptfasen er de økonomiske effektene av null-pluss alternativet overordnet oppdatert for sammenligning med det videreførte Mjøssykehus-alternativet.

Forutsetningene for oppdateringen av null-pluss alternativet er beskrevet i *økonomiske analyser*, vedlegg 5 til konseptfaserapporten for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Utredningen av driftsgevinster for null-pluss alternativet ble gjennomført av Sykehuset Innlandet HF i konseptfasens steg 1. Basert på virksomhetsinnholdet i erstatningssykehuset på Hamar og innholdet i det forutsatte økte arealbehovet for erstatningssykehus på Hamar i steg 2, er vurderingen at dette ikke gir grunnlag for å endre gevinstestimaterne for null-pluss alternativet fra steg 1, utover en lønns- og prisjustering.

Totalt bruttoareal bygningsmasse i Sykehuset Innlandet HF, inkludert nybygg, vil i Mjøssykehus-alternativet være om lag 266 000 kvadratmeter, mens null-pluss alternativet vil ha en total bygningsmasse på om lag 328 000 kvadratmeter. Forskjellen i totalareal mellom strukturalternativene er i hovedsak forklart av arealet for virksomheten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hvor dagens bygningsmasse på Reinsvoll og Sanderud er lite arealeffektiv sammenlignet med konseptfaseutredningens nye arealer for denne tjenesten. Forskjellen på 145 000 kvadratmeter bygningsmasse i øvrig struktur mellom alternativene, eksklusive nybyggene, framkommer av differansen mellom 132 000 kvadratmeter i Mjøssykehus-alternativet mot 277 000 kvadratmeter i null-pluss-alternativet.

Helse Sør-Øst RHF vurderer at forutsetningene for den overordnede oppdateringen av null-pluss alternativet i konseptfasens steg 2 er rimelige. Den oppdaterte overordnede analysen, sammen med sensitivitetsbetraktningene knyttet til de forutsetningene som er lagt til grunn, tilsier at Mjøssykehus-alternativet har en bedre langsiktig økonomisk bæreevne sammenlignet med null-pluss alternativet.

2.4. Finansiering, herunder alternative låne- og egenfinansieringsandeler og statlig tilskudd

I prosjektutredningen er det forutsatt at investeringene finansieres med totalt 90,2 prosent lån fra Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert 100 prosent investeringslån for universitetsarealene. Låneadgangen for prosjektet er begrenset oppad til 90 prosent av forventet projektkostnad (P50-estimat) for sykehusarealene og 100 prosent av P85-estimatet for universitetsarealene. Egenfinansieringen til Sykehuset Innlandet HF er forutsatt dekket med trekk på helseforetakets basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF.

Investering og finansiering	Mjøssykehuset, inkludert tillegg stråleterapi		Elverum, Tynset og luftambulansebase		Totalt	
	MNOK	Andel	MNOK	Andel	MNOK	Andel
Investering						
Prosjektkostnad P50 eks. universitetsareal	17 378	94 %	489	100 %	17 867	94 %
Prosjektkostnad P50 universitetsareal	427	2 %	-	0 %	427	2 %
Ikke-bygggnær IKT*	722	4 %	-	0 %	722	4 %
Sum projektkostnad	18 527	100 %	489	100 %	19 016	100 %
Finansiering						
Investeringslån HOD	16 717	90,2 %	440	90,0 %	17 157	90,2 %
Egenkapital i form av basisfordring	1 810	9,8 %	49	10,0 %	1 859	9,8 %
Sum finansiering	18 527	100 %	489	100 %	19 016	100 %

Tabell 4 Sammenstilling av investeringskostnad, eks. eventuelle tomteervervskostnader, fordelt på forutsatt låne- og egenfinansiering i prosjektutredningen. Beløp i millioner september 2024-kroner. *) Sykehuset Innlandet HF dekker investeringen i form av årlig tjenestepreis fra Sykehuspartner HF.

I spesialisthelsetjenestens låneregime søkes Helse- og omsorgsdepartementet om investeringslån basert på konseptfaseutredningen inklusive ekstern kvalitetssikring. Ved

Stortingets tilslutning innvilges rammen for investeringslånet på statsbudsjettet for et gitt år. Deretter melder de regionale helseforetakene inn behov for framtidig, periodisert låneuttak basert på prosjektets oppdaterte gjennomføringsplan/pådragsprofil to ganger per år. Låneutbetalingene vedtas deretter på det enkelte års statsbudsjett.

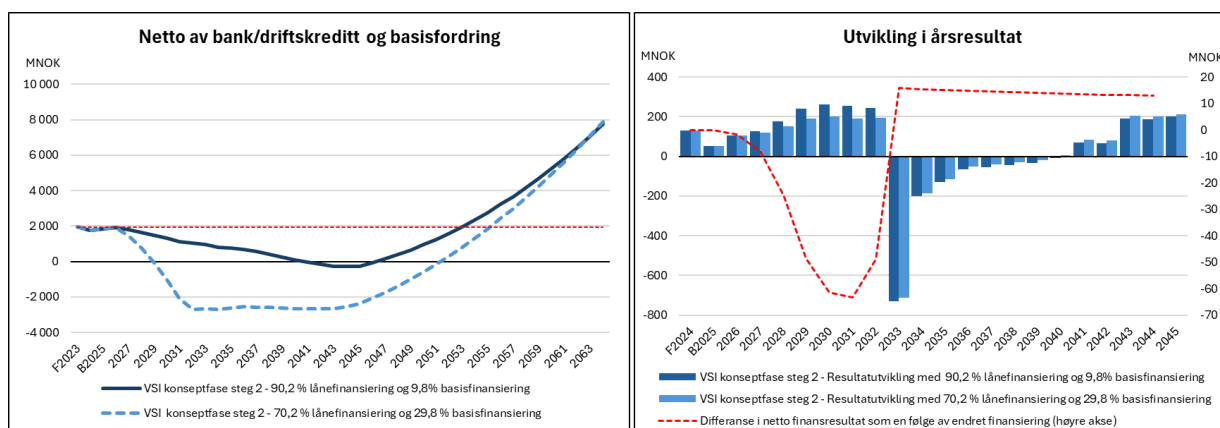
I dette regimet har de regionale helseforetakene mulighet til å melde inn et lavere lånebehov dersom prosjektutviklingen tilsier det, eller å tilbakebetale eventuelle overskytende lånemidler etter ferdigstilling av prosjektet.

Prosjektet videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF med utbyggingen av Mjøssykehuset er et megaprojekt med risiko for at byggekostnadene kan overstige forventet projektkostnad (P50-estimat). Dette understrekes både av gjennomført usikkerhetsanalyse og ekstern kvalitetssikrer. Ekstern kvalitetssikrer anfører at *«foreliggende usikkerhetsanalyse for Mjøssykehuset gjenspeiler usikkerhetsbildet på et overordnet nivå, men vi støtter fasilitators vurdering av at analysen bærer preg av optimisme, og at resultatet slik det foreligger vil gi prosjektet krevende rammer»*. Det anbefales derfor at det regionale helseforetaket søker om et finansieringstilsagn basert på 90 prosent av forventet projektkostnad (P50-estimat) for sykehusarealene og 100 prosent av P85-estimatet for universitetsarealene selv om det skal arbeides videre med muligheter for kostnadsreduksjon og effektiv prosjektgjennomføring.

Helse Sør-Øst RHF kan likevel beslutte alternative låne- og egenfinansieringsandeler for Sykehuset Innlandet HF, og finansieringssammensetning foreslås besluttet ved oppstart forprosjekt. Helseforetaket har en oppspart basisfordring mot Helse Sør-Øst RHF på om lag 2,3 milliarder kroner per 31. desember 2024. Denne basisfordringen er estimert å være om lag 1 milliard kroner per utgangen av 2033 etter belastning av helseforetakets egenfinansiering for prosjektet (9,8 prosent av projektkostnad; P50-estimat). Basisfordringen kan også være negativ avhengig av endelig finansieringssammensetning.

Effekten av en lavere låneandel/høyere egenfinansieringsandel (endret andel bruk av basisfordring) for helseforetaket er imidlertid begrenset. Kapitalkostnadene, i form av avskrivninger og renter, vil i liten grad påvirkes av finansieringsandelene. Økt egenfinansiering vil redusere helseforetakets renteinntekter/øke rentekostnader fra basisfordringen, noe som motvirker renteeffekten av lavere lånefinansiering. Det vil likevel være en periodiseringseffekt for helseforetaket, med et lavere finansresultat i byggeperioden og et noe høyere finansresultat etter at ny sykehusstruktur er tatt i bruk. Dette som følge av at byggelånsrenter for lånefinansiering, som legges til lånets hovedstol, erstattes av løpende belastning av renter på egenfinansiering i form av trekk på helseforetakets basisfordring.

Likviditetsframskrivningen for helseforetaket i form av netto av bank/driftskreditt og basisfordring påvirkes derimot av finansieringsandelene. En økt egenfinansieringsandel vil medføre økt behov for mellomfinansiering fra det regionale helseforetaket, og Sykehuset Innlandet HF vil reetablere investeringsevnen på et senere tidspunkt. Ved utløpet av analyseperioden er netto likviditetsframskrivning på samme nivå uavhengig av finansieringsandelene. Merk at startpunktet for likviditetsframskrivningene i figuren til venstre under er negativt påvirket av historiske premieavvik knyttet til pensjon for perioden 2009 - 2024 på om lag 1,2 milliarder kroner for Sykehuset Innlandet HF.



Figur 3 Eksempel på effekt av endrede finansieringsandeler på helseforetakets netto likviditetsframskrivning (til venstre) og helseforetakets framskrevne årsresultat (til høyre) ved å redusere lånefinansiering med 20 prosentpoeng (3,5 milliarder kroner) av total investering og øke egenfinansiering tilsvarende. Ved mindre endringer i finansieringsandelene vil forskjellene mellom alternativene reduseres tilsvarende.

Egenfinansieringen til Sykehuset Innlandet HF kan også økes ved å forutsette at deler av helseforetakets positive resultater fram til ny sykehusstruktur tas i bruk skal inngå i den endelige finansieringsplanen. En slik forutsetning vil medføre at helseforetakets planlagte investeringer i bygg, medisinsk-teknisk utstyr og annet i perioden 2026 – 2032 måtte ha blitt redusert. Dette kan blant annet påvirke den forutsatte andelen for medflytt av funksjonsutstyr inn i Mjøssykehuset, og øke nødvendige investeringer i funksjonsutstyr i byggeprosjektet. Sykehuset Innlandet HF framhever i styresak 025-2025 at «det er nødvendig å øke resultatmålet gjennom perioden for å få en mer bærekraftig økonomi fram mot ny sykehusstruktur og en mulighet for investeringer i nødvendig medisinsk-teknisk utstyr». Dette underbygges ved at helseforetaket er blant helseforetakene i Helse Sør-Øst med høyest gjennomsnittsalder på medisinsk-teknisk utstyr. Videre beskriver tilstandsrapporteringen for byggenes tekniske tilstand, referer styresak 004-2025 *Tilstand for eiendomsporteføljen og evaluering av internhusleieordningen*, at Sykehuset Innlandet HF har et oppgraderingsbehov anslått til om lag 725 millioner kroner over de neste fem årene for å oppgradere bygningskomponenter i tilstandsgrad 2 eller 3.

Egenfinansieringen til Sykehuset Innlandet HF kan også økes ved å forutsette at salgsmidler for sykehusene som skal avhendes skal inngå i finansieringsplanen. I prosjektoppdatt økonomisk langtidsplan 2025-2028 er avhending av Hamar, Gjøvik, Reinsvoll og Sanderud forutsatt å gi om lag 300 millioner kroner i samlede salgsmidler. Dette er basert på et estimat av et meglerfirma for næringseiendommer for en tid tilbake. Estimatenes er svært usikre i nåværende fase. Salgsmidlene er i prinsippet foreløpig forutsatt investert i varige verdier ved øvrige lokasjoner i helseforetaket. I Figur 3 over (til høyre) ligger et forutsatt regnskapsmessig tap for salg av eiendom på om lag 330 millioner kroner i 2033, som følge av at de bokførte verdiene av eiendommene er større enn estimert salgsværdi.

Endrede finansieringsandeler som inkluderer en andel statlig investeringstilskudd framfor lån, vil derimot kunne gi Sykehuset Innlandet HF lavere netto kapitalkostnader.

Flere forhold tilsier investeringstilskudd for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Mjøssykehuset innebærer en investering på om lag 1,7 ganger Sykehuset Innlandet HF's totale driftsinntekter i 2024. Dette er høyt sammenlignet med andre sammenlignbare helseforetak. I tillegg medfører demografiutviklingen i Innlandet en lavere realvekst i

helseforetakets driftsinntekter enn for gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. For perioden fra 2022 til budsjett 2025 hadde Sykehuset Innlandet HF en realvekst i driftsinntekter som var 1,6 prosentpoeng lavere enn foretaksgruppen. Dette gjør prosjektet mer krevende økonomisk for Sykehuset Innlandet HF sammenlignet med andre helseforetak med store byggeprosjekt.

Foretaksmøtets vedtak om styrking av tilbudet ved sykehusene i Elverum og på Tynset (sammenlignet med de planene som lå til grunn for styresak 102-2022 *Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF*) har medført en mer krevende økonomisk situasjon for helseforetaket.

Mjøssykehusets plassering på Moelv medfører ekstra behov for tiltak for å understøtte rekruttering, referer styresak 015-2023 *Sykehuset Innlandet HF – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, tilleggsoppdrag*.

For foretaksgruppen Helse Sør-Øst innebærer Mjøssykehuset et nytt megaprojekt i porteføljen, med stor grad av samtidighet i prosjektgjennomføringen med nye Aker og nye Rikshospitalet. Det vil dermed både være samtidighet i investeringspådrag, hvor prosjektene kan risikere å møte samme negative markedsutvikling, og samtidighet i forutsatt realisasjon av driftsgevinster som følge av prosjektene. Dette medfører økt risiko for foretaksgruppen, og et investeringstilskudd vil redusere denne risikoen.

Sykehusutvalget, som blant annet så på ordningen for finansiering av sykehusbygg, kom med sin tilrådning i NOU 2023: 8 *Felleskapets sykehus*. Regjeringen oppsummerte Sykehusutvalgets tilrådning i Meld. St. 9 (2023-2024) *Nasjonal helse og samhandlingsplan 2024-2027*:

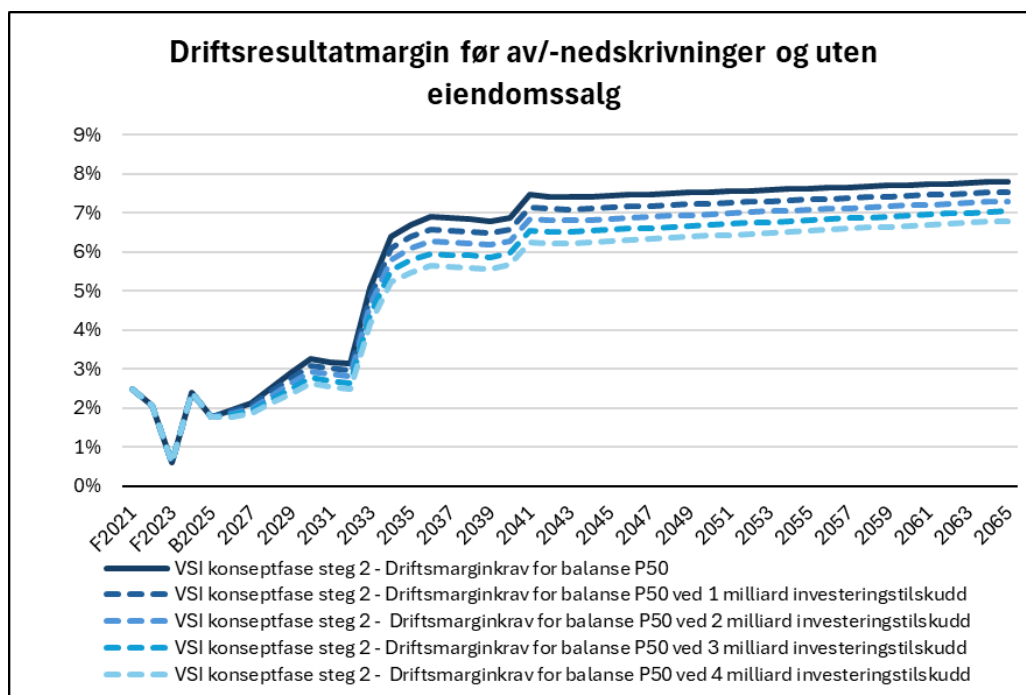
Sykehusutvalgets tilrådning var at helseforetakene fortsatt skal ha samlet ansvar for drift og investeringer. Utvalget mente at dette legger best til rette for effektiv ressursbruk og regional prioritering av investeringsprosjekter. Utvalget foreslo å forbedre tilgangen på likviditet ved at egenkapitalkravet reduseres fra 30 prosent til 10 prosent, bedre rentebetingelser ved at rentemodellen for alle lån endres tilbake til slik den var før 2018, og at helseforetakene kompenseres for 75 prosent av faktiske avskrivningskostnader.

Regjeringen sluttet seg i stortingsmeldingen til tilråningen til Sykehusutvalget om å redusere egenkapitalkravet og endre rentebetingelsene. Dette ble senere fulgt opp i statsbudsjettet for 2025. I Stortingets behandling av St. Meld 9 (2023-2024) ble også temaet avskrivningskostnader behandlet. Stortinget fattet følgende vedtak: «*Stortinget ber regjeringen utrede ulike ordninger for å håndtere avskrivningskostnader i sykehus og alternative modeller for rentekompensasjon for sykehusbygg.*» Et investeringstilskudd vil bidra til å håndtere avskrivningskostnader og gi lavere netto kapitalkostnader.

Ved behandlingen av St. prp. nr 1 (2003-2004) bevilget Stortinget investeringstilskudd til tre særskilte prosjekter; nye Ahus, nye St. Olavs hospital og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet. Etter dette har statlig investeringstilskudd til byggeprosjekter kun blitt gitt til byggingen av protonterapisentrene ved Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF. Dette hadde sin bakgrunn i oppdrag gitt til de regionale helseforetakene om å utrede etableringen av slik behandling i Norge og Stortingets vedtak om å planlegge for to protonsentre. Vedtaket om byggingen av protonsentret ved Oslo universitetssykehus HF

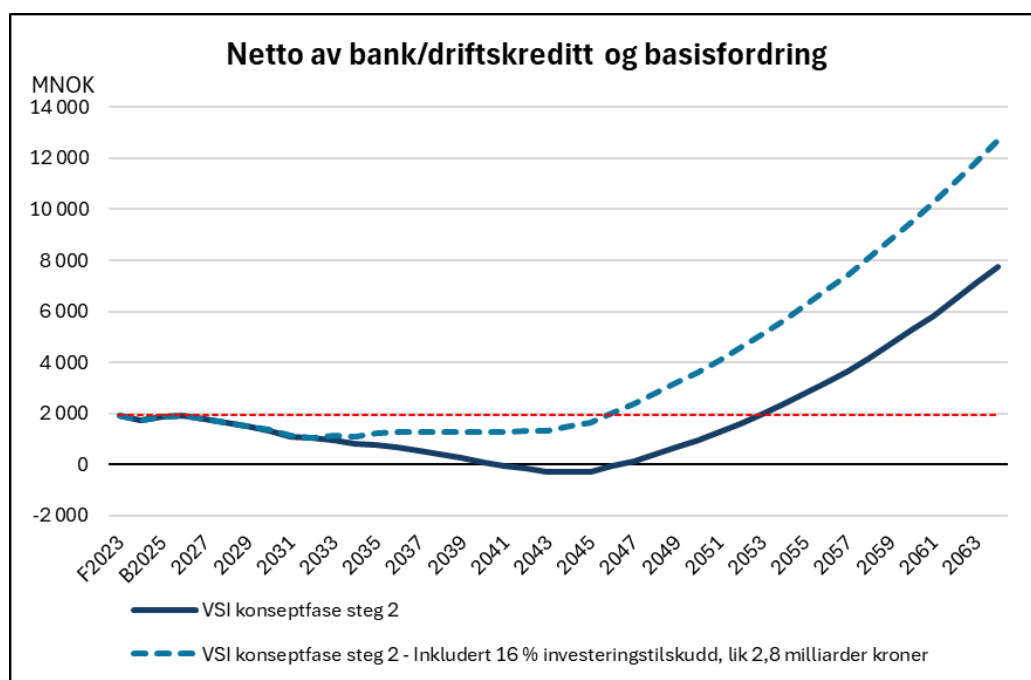
har dermed ikke vært gjenstand for en regional prioritering på lik linje med øvrige byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.

De økonomiske analysene for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF viser at helseforetaket må realisere en langsiktig driftsmargin på om lag 7,3 prosent for å håndtere de økte kapitalkostnadene fra prosjektet. Et investeringstilskudd vil redusert driftsmarginkravet med om lag 0,3 prosentpoeng per milliard kroner i tilskudd under de øvrige forutsetninger som ligger til grunn for prosjektoppdateret økonomisk langtidsplan 2025-2028 for helseforetaket.



Figur 4 Illustrativ effekt på driftsmarginkravet for Sykehuset Innlandet HF ved ulike størrelser på investeringstilskudd

Prosjektoppdatert økonomisk langtidsplan 2025-2028 viser at Sykehuset Innlandet HF reetablerer netto likviditetsposisjon i 2054, som er 22 år etter at ny sykehusstruktur tas i bruk. Andre helseforetak med store byggeprosjekter viser etter planen en kortere tid for å reetablere netto likviditetsposisjon. Oslo universitetssykehus HF (uten effekt fra salg av Ullevål og SSE) og Vestre Viken HF (uten salg av dagens Drammen sykehus, Bragernes og Blakstad) reetablerer sin investeringsevne om lag 14 år etter at nye bygg tas i bruk. Dersom Sykehuset Innlandet HF også skulle kunne reetablere sin investeringsevne 14 år etter at ny sykehusstruktur tas i bruk, vil det kreve reduserte netto kapitalkostnader tilsvarende et investeringstilskudd på om lag 2,8 milliarder kroner (16 prosent).



Figur 5 Effekt på netto likviditetsframskrivning av et investeringstilskudd på 2,8 milliarder kroner

Forutsatte andeler mellom lån og egenfinansiering påvirker tiden det tar å reetablere investeringsevne. En låneandel på 70 prosent, som ligger til grunn for Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, ville økt tiden Sykehuset Innlandet HF etter planen bruker for å reetablere likviditetsnivået med om lag tre år. Isolert skulle dette tilsi et større behov for investeringstilskudd for at Sykehuset Innlandet HF skulle reetablere sin investeringsevne tilsvarende som Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.

Et investeringstilskudd på 16 prosent av forventet prosjektkostnad vil redusere kravet til kostnadstilpasning og gevinstuttak med om lag 100 millioner kroner årlig.

2.4.1. Søknad om finansiering

Søknad om finansiering til Helse- og omsorgsdepartementet utformes på grunnlag av omfanget i konseptfasen. Samlet investeringsomfang, som omfatter Mjøssykehuset, luftambulansebase på Elverum, tilpasning og rehabilitering av sykehusene på Elverum og Tynset og endrede forutsetninger for stråleterapi, utgjør 19 046 millioner kroner (P50-estimat). Dette inkluderer arealer til universitetene, ikke-byggnær IKT og en øvre ramme for kostnader forbundet med mulige tomteerverv på 30 millioner kroner. Totalt beløp for omsøkt ekstern finansiering framkommer som 90 prosent av beregnet P50-estimat, men

med 100 prosent lånefinansiering av kostnadsramme P85 for universitetsarealer, og utgjør 17 280 millioner kroner (prisdato: september 2024).

Byggelånsrenter i gjennomføringsperioden vil bli lagt til hovedstolen på investeringslånet, slik at endelig lånebeløp øker tilsvarende. I tillegg vil også framtidig prisregulering av gjenværende finansieringsramme etter SBED-indeksen («lønns- og prisregulering») medføre økning i det endelige finansieringsbeløpet.

Det pågår dialog med universitetene om intensjonsavtaler som inkluderer prinsipper for leieberegning av universitetsarealene som er planlagt på Mjøssykehuset, i henhold til Prop. 1 S (2017-2018) side 99. Her fastslås at helseforetakene er eiere av universitetsarealene, og at universitetene betaler en kostnadsdekkende husleie som dekker forvaltning, drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader. Sykehuset Innlandet HF har budsjettert med en kostnadsdekkende forventet leieinntekt for universitetsarealene basert på konseptrapportens tall.

2.5. Forhold som krever særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet

2.5.1. Rekruttere og beholde ansatte

Å opprettholde og styrke rekruttering og beholde ansatte i Sykehuset Innlandet HF er vesentlig for å lykkes med prosjektet. Det er flere forhold å være oppmerksom på i dette arbeidet, hvor Innlandets demografiske utvikling, Mjøssykehusets plassering og omstillingen organisasjonen skal igjennom, er områder som påvirker Sykehuset Innlandet HF's rekrutteringsevne.

Innlandet er preget av en demografisk utvikling som over tid tilsier flere eldre og en lavere andel i arbeidsfør alder. Dette gir Sykehuset Innlandet HF tilgang på en mindre gruppe å rekruttere fra, noe som underbygger viktigheten av både å arbeide for å rekruttere og beholde ansatte, samtidig som det må legges til rette for løsninger som er bemanningseffektive.

En annen årsak til rekrutteringsrisikoen er plasseringen av Mjøssykehuset i Moelv, noe som vil gi økt reisevei for mange ansatte. Gode trafikale løsninger med tilgang til parkering ansees som viktige risikoreduserende tiltak som vil være prioriterte i det videre arbeidet. Det forutsettes også et tett samarbeid med kollektivtilbyderne i Innlandet, slik at et godt kollektivtilbud kommer på plass til åpning av nytt sykehus. Videre vil Helse Sør-Øst RHF oppfordre Ringsaker kommune til å prioritere arbeidet med by- og områdeutvikling rundt sykehuset, slik at utbyggere opplever det som attraktivt å starte utviklingsprosjekter i området.

Det er i tidligere styresaker og tilleggsoppdrag beskrevet risiko ved omfang og kompleksitet i omstillingsprosessene organisasjonen må igjennom. Utvikling av felles kultur- og møtearenaer for ansatte som skal arbeide sammen, samt medvirkning og involvering i arbeidet med nytt sykehus og nye løsninger er risikoreduserende arbeid som vil være prioriterte framover. Mjøssykehuset vil på den andre siden gi ansatte tilgang til et større fagmiljø noe som vil påvirke rekrutteringsevnen positivt. Det samme gjelder Universitetet i Oslo og NTNUs beslutninger om å desentralisere medisinstudiet til Innlandet, noe

som vil bidra til å styrke fag- og forskningsaktivitetene og dermed rekrutteringen til Innlandet.

2.5.2. Regulering og rekkefølgekrav

Som orientert om i styresak 033-2025 har det gjennom skriftlig dialog med Ringsaker kommune blitt avklart hvilken ansvarsfordeling for rekkefølgekrav kommunen ser for seg. Samtidig er ikke reguleringsarbeidet ferdig, slik at det fortsatt eksisterer risiko for uforutsette endringer som vil gi økte kostnader. Det er forventet at reguleringsplanen skal sendes til behandling og høring i løpet av forprosjektfasen. Gjennom denne prosessen vil det komme høringsinnspill som må behandles av kommunen og som vil kunne få konsekvenser for rekkefølgekrav. I den forbindelse har også Statsforvalter mulighet til å varsle innsigelser dersom de mener at foreslått regulering ikke ivaretar vesentlige nasjonale og regionale interesser. Det er nødvendig med en forutsigbarhet for rekkefølgekrav og kostnadene ved disse, og søknaden om finansiering vil inkludere de kjente forholdene. Eventuelle ytterligere rekkefølgekrav fra statlige myndigheter må følges av en tilsvarende økning av finansieringen, i form av investeringstilskudd. Jf. tidligere omtale av behovet for investeringstilskudd.

2.5.3. Risiko for økte investeringskostnader

Sammenligning med øvrige sykehusprosjekter, gjort av *Bedre megaprojekter*, viser at investeringsestimatet er robust, og på linje med øvrige megaprojekter i Helse Sør-Øst. Samtidig peker både KSK og usikkerhetsanalysen på risikoen for at kostnadene kan øke i senere faser av prosjektet, både på grunn av hendelser belyst i usikkerhetsanalysen og som konsekvens av ukjente og uforutsigbare ekstremhendelser.

Den viktigste usikkerheten er markedsusikkerhet, fremdrift og kompleksitet i gjennomføringen og prosjektering og modenhet, hvor markedsusikkerhet er definert som den absolutt største. Det vil være avgjørende å gjøre gode markedsanalyser for å få forståelse av markedet, og kunne utarbeide kontraktstrategier som gir god konkurranse og tilbydere til alle kontrakter.

I tråd med gjeldende praksis omfatter ikke usikkerhetsanalysen større premissendringer i det videre prosjektforløpet. Et eksempel på dette er eventuelle krav om tilfluktsrom, som vil bli behandlet som en premissendring med tilhørende tilleggsfinansiering, dersom krav til dette blir vedtatt.

Usikkerhetsanalysen ivaretar heller ikke ekstremhendelser, dvs hendelser med liten sannsynlighet, men stor konsekvens, ofte omtalt som sorte svaner i megaprojektlitteraturen. Med den varigheten dette prosjektet har, øker sannsynligheten for ekstremhendelser og sorte svaner, noe som igjen kan påvirke investeringskostnadene.

Som beskrevet i orienteringssaken 033-2025 vil Helse Sør-Øst RHF frem mot oppstart av forprosjektet utarbeide krav til hvilke styringsmål forprosjektet skal ha. Dette, sammen med øvrige tiltak beskrevet under kapittel 2.6 Plan for det videre arbeidet, ansees som viktige tiltak for å ha god styring av et megaprojekt med betydelig risiko.

2.5.4. Arbeid med kuttlister

Kuttlister brukes for å identifisere og prioritere områder som grunnlag for eventuelle kostnadsreduksjoner i gjennomføringsfasen. Dette kan inkludere valg av materialer, tekniske løsninger og optimalisering av romfunksjoner.

Veileder for tidligfasen for sykehusbyggprosjekter stiller krav til at det skal foreligge kuttliste som del av leveransen i forprosjektet. Årsaken til dette er at prosjektet først i forprosjektfasen blir tilstrekkelig detaljert til å kunne identifisere og vurdere mulige kostnadsbesparelser.

Kuttlistene skal inneholde konkrete forslag til kostnadsreduksjoner som kan effektueres på ulike tidspunkt i gjennomføringsfasen. Den økonomiske effekten skal synliggjøres, og eventuelle konsekvenser skal beskrives. Det er vesentlig at noen av kuttene skal kunne gjennomføres sent, og at de er av tilstrekkelig omfang gitt den risikoen som ligger i prosjektet. Arbeidet med kuttlister henger på denne måten nøye sammen med fremdriftsplanlegging og mulig etappevis utbygging, slik at beslutning om eventuelle kutt kan sees i sammenheng med den risikoen som allerede er lukket.

I arbeid med kuttlister er det risiko for at det utarbeides forslag til kutt som reduserer prosjektets måloppnåelse og fører til økte driftskostnader over tid. Det er derfor viktig å sørge for at det gjøres helhetlige vurderinger av livssykluskostnader opp imot investeringskostnaden. Kutt som reduserer investeringskostnaden, men øker driftskostnadene for Sykehuset Innlandet HF må unngås. Eventuelle forslag til kutt som berører virksomhetsinnholdet eller funksjonaliteten må vurderes nøye mot gevinstplanene for prosjektet, basert på en helhetlig kost/nytte vurdering. Det er også vesentlig at eventuelle kutt ikke går på bekostning av prosjektets tilnærming til standardisering.

Gitt rekrutteringsrisikoen for helseforetaket, vil det være viktig å unngå kutt som går utover Mjøssykehuset som en attraktiv arbeidsplass. Prosjektet må i størst mulig grad identifisere mulige kutt og effektiviseringstiltak som kan iverksettes uten å redusere omfang og kvalitet for ansatte og pasienter, eller som reduserer muligheten for å realisere driftsgevinstene.

2.6. Plan for det videre arbeidet

Som forberedelse til forprosjektfasen vil Helse Sør-Øst RHF bruke de kommende månedene til å spesifisere eierkravene til forprosjektet. Målet med dette er å legge til rette for reduksjon av risiko og kostnader ved at det gjennomføres et forprosjekt med høy grad av gjenbruk fra andre prosjekter og minst mulig omprosjektering, og som underbygger det som må til for en effektiv gjennomføring av prosjektet. Dette arbeidet vil danne grunnlag for å anbefale styringsmål og mandat for forprosjektet. Parallelt vil Helse Sør-Øst RHF forberede krav til organiseringen og utarbeide en plan for hvordan prosjektet skal bemannes for å sørge for at eierkravene ivaretas på best mulig måte. Oppstart av forprosjektet besluttet når søknad om finansering er behandlet.

2.6.1. Gjenbruk av prosjekterte løsninger og materiale

Ved å gjenbruke prosjekterte løsninger og prosjektert materiale i form av tegninger og modeller fra tidligere sykehusbyggprosjekter, kan man spare tid og redusere kostnader i arbeidet med prosjektering og utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for byggingen. Prosjekterte

løsninger som er utviklet basert på kunnskap, erfaringer og medvirkning fra brukere og ansatte i andre relevante sykehusbyggprosjekter, skal vurderes å brukes på nytt i prosjektet. Dette skal bidra til høyere kvalitet og færre feil i gjennomføringen.

For å redusere risiko og kostnader ved å forenkle byggeprosessen og redusere kompleksiteten skal det etableres en strukturert prosess for innsamling og analyse av erfaringer, metoder og løsninger fra tidligere sykehusbyggprosjekter. Det skal kartlegges hvilke prosjekterte løsninger som kan gjenbrukes, og hvordan dette materialet skal benyttes inn i prosjekteringen. I tillegg har sammenligningen med andre prosjekter (benchmarking) vist at de mindre prosjektene bygges til vesentlig lavere kvadratmeterpris enn de store megaprojektene. Å forstå hvordan disse prosjektene har vært organisert og bygget, vil gi viktige innspill til hvilke krav som må stilles til forprosjektet.

Som deltaker i utviklingsprogrammet *Bedre megaprojekter* har Helse Sør-Øst RHF tilgang på et nettverk av offentlige og private byggherrer med erfaring fra megaprojekter. Spesielt har olje- og energisektoren lang erfaring med megaprojekter. Selskapene har gjennom strenge avkastningskrav de siste tiårene, forbedret effektiviteten i sine prosjekter ved hjelp av avanserte digitale verktøy, standardisering og industrialisering. Dette er prinsipper som allerede er benyttet i nye Stavanger universitetssykehus, og som vil være viktig å lære mer om og videreutvikle i prosjektet.

2.6.2. Standardisering og industrialisert byggeprosess

Helse Sør-Øst RHF har en ambisjon om å levere et Mjøspsykehus med best mulig kvalitet og bærekraft til lavest mulig kostnad. For å kunne nå et slikt mål peker erfaringer på at prosjektering og bygging må standardiseres og industrialiseres i betydelig større grad enn vi har gjort fram til i dag. Forskning og empiri viser at standardisering i gjennomføring av byggprosjekter har flere positive effekter. Dette inkluderer bedre kvalitet, raskere framdrift, økt sikkerhet og lavere ressursbruk og kostnader.

Standardiserte løsninger gir en repetisjonseffekt i byggeprosessen som gjør det mulig å gjennomføre arbeidet raskere og dermed mer kostnadseffektivt, og sikrer i tillegg en jevn og høy kvalitet på løsninger, materialer og utførelse. Dette reduserer risikoen for feil og mangler, og dermed tid og ressurser brukt på rette disse. Standardisering gir også en fleksibilitet ved at standardiserte moduler og komponenter enkelt kan tilpasses ulike behov og funksjoner, noe som gjør det enklere å bygge om eller utvide.

Nye Stavanger universitetssykehus har demonstrert at fullskala digitalisering og standardisering har gjort det mulig å industrialisere byggingen ved å benytte prefabrikkerte elementer i stor skala. Blant annet ble fasadeelementer, trapper og søyler produsert på fabrikk i nærheten av byggeplass, og alle bad produsert og levert flatpakket som gjør det mulig å installere eller fjerne disse ved behov. Dette er eksempler på tiltak som har bidratt til å redusere byggetiden og økt effektiviteten.

2.6.3. Bruk av digitale verktøy og KI for effektivisering av prosjektering og prosjektstyring

Riktig bruk av digitale verktøy i byggeprosjekter gjør arbeidsprosesser mer effektive, forbedrer kommunikasjon og samarbeid, og øker produktiviteten og kvaliteten på leveransene. Helse Sør-Øst RHF planlegger å utvikle en strategi for bruk av digitale verktøy i prosjektering og prosjektstyring, basert på erfaringene fra nye Stavanger universitetssykehus.

Kunstig intelligens (KI) har vist seg å være nyttig i arbeidet med prosjektering og utredninger som ledd i en prosjektutvikling. Testing av KI er et fokusområde i samarbeidet med *Bedre megaprojekter*, og hvordan dette kan brukes i forprosjektet, vil bli undersøkt videre.

2.6.4. Vurdere behovet for tilpasning i bygningsmassen

Forskning på megaprojekter viser at store, komplekse prosjekter med mange grensesnitt bør deles opp i mindre, håndterbare deler ved organisering, entrepriser og bygging. Dette gjør det lettere å administrere, overvåke og kontrollere hvert enkelt delprosjekt, noe som bidrar til å redusere risiko, øke fleksibiliteten og forbedre styringen. I tillegg gjør mindre delprosjekter det mulig å identifisere og isolere problemer tidlig, slik at de i minst mulig grad påvirker resten av prosjektet.

For å videreutvikle strategien om oppdeling og samtidig unngå såkalt kostnadssmitte, der høye kostnader i én funksjon eller en del av prosjektet sprer seg og øker kostnadene i andre deler, vil Helse Sør-Øst RHF vurdere nødvendige tilpasninger av planlagt konsept for bygningsmassen før oppstart av forprosjektet. Eventuelle behov for tilpasninger må vurderes opp imot planlagte gevinster og driftskonsept før de iverksettes.

2.6.5. Gjennomføringsstrategi og eventuell etappevis utbygging

I henhold til styresak 102-2022 *Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF*, og vedtak i foretaksmøtet 21. november 2023, er det gjennomført en utredning av trinnvis utbygging. Utredningen skulle belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom.

Utredningen ble presentert for styret i Helse Sør-Øst RHF i styresak 015-2023 *Sykehuset Innlandet HF – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, tilleggsoppdrag*, og angir begrensede risikoreduserende gevinster ved en trinnvis utbygging utover det som kan ivaretas med en trinnvis innflytting over en kortere periode. De økonomiske analysene viste at en samlet utbygging vil medføre en noe bedre langsiktig økonomisk bæreevne for Sykehuset Innlandet HF og for Helse Sør-Øst.

Erfaring fra store byggeprosjekter viser imidlertid at risikoen kan reduseres ved å etablere en gjennomføringsstrategi der både bygningskonseptet og gjennomføringen er delt opp og planlagt slik at byggearbeidene kan utføres i etapper. Ved å styre parallelliteten i byggeprosessen kan risiko lukkes underveis. Som orientert om i styresak 033-2025, er det i konseptfasens steg 2 gjort innledende analyser av hvordan dette kan gjøres, uten at total byggetid forlenges. Videre analyser av gjennomføringsmetoder, sammen med markedsanalyser, vil være avgjørende for å vurdere hvilke kontraktstrategier som bør velges.

Parallelt med dette arbeidet vil det bli startet vurderinger av fremdrift for arbeidene på Elverum, Tynset og luftambulansebase i Elverum.

2.6.6. Styrke prosjektorganisasjonen for å kunne ivareta beste praksis prosjektstyring og usikkerhetsstyring

Ledelse av et megaprojekt krever god eierstyring og en prosjektledelse med bred kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, som kan håndtere komplekse problemstillinger.

God eierstyring er viktig for å lykkes med et megaprojekt. Helse Sør-Øst RHF arbeider kontinuerlig for å være en forutsigbar og tydelig prosjekteier. Ved å ha klare beslutningsprosesser, tydelighet i roller og ansvar, samt god kommunikasjon og oppfølging av forventningene til prosjektledelsen bidrar prosjekteier til god fremdrift og kvalitet i prosjektet. Å utvikle egen kompetanse, prosesser og rutiner knyttet til eierstyringen vil være prioriterte oppgaver i det videre arbeidet.

Basert på læring fra tidligere prosjekter og innspill fra *Bedre Megaprojekter*, vil Helse Sør-Øst RHF utvikle hvilke roller, kompetanse og erfaring som trengs for å lede prosjektet. Tilstrekkelig kapasitet og tverrfaglig kompetanse ansees som kritiske suksessfaktorer for å kunne drive god prosjekt- og usikkerhetsstyring.

Megaprojektliteraturen underbygger hvor viktig ledelse og teamet rundt prosjektledelsen er for å lykkes. For å tiltrekke seg de beste ressursene må både Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF sammen bidra til at videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF blir et attraktivt byggeprosjekt.

2.6.7. Forberedelser og avklaringer i Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF har en avgjørende rolle i arbeidet med å forberede egen organisasjon på de store endringene i sykehusstrukturen i Innlandet. Helseforetaket vil overta eierskapet og ansvaret for driften av Mjøssykehuset når det står ferdig. Dette vil kreve fortsatt eierskap til den videre prosjektutvikling, og god involvering og medvirkning fra ansatte, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Mottaksprosjektet vil ha ansvar for å gjennomføre medvirkning, som grunnlag for de nødvendige avklaringene Sykehuset Innlandet HF må gjøre for å sørge for en effektiv gjennomføring av byggeprosjektet. Medvirkning og utvikling av organisasjonsutvikling er viktige risikoreduserende tiltak som bidrar til gode løsninger og eierskap til prosjektet. Sykehuset Innlandet HF vil ha et særlig ansvar for å forberede organisasjonen på nye IKT-løsninger og nye arbeidsprosesser. Helseforetaket har i tillegg et ansvar for å starte planlegging og prioritering av hvor stor andel av eksisterende utstyr som skal gjenbrukes, slik at forutsatt medflyttingsgrad blir ivaretatt.

Sykehuset Innlandet HF skal, gjennom aktiv involvering av brukere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, bidra til riktige prioriteringer for å realisere prosjektets gevinster. Medvirkningsprosessene må tilpasses prosjektets krav til standardisering og gjenbruk av prosjekterte løsninger. Det må også utarbeides en plan for hvilke problemstillinger som må avklares og besluttes før oppstart av forprosjektet, for å unngå omprosjektering og kostbare endringer i det videre arbeidet.

3 Administrerende direktørs anbefaling

Konseptutredningen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF legges med dette fram for styret for beslutning.

Bakgrunnen for prosjektet er Sykehuset Innlandet HFs utfordringer med en spredt fordeling av funksjoner på tvers av geografi og sykehus. Strukturen er kostnadsdrivende fordi den medfører et uforholdsmessig stort behov for vedlikehold av bygg og duplisering av medisinsk teknisk utstyr, beredskap og vaktlag, som følge av drift på mange steder. På grunn av tilstanden ved sykehusbygget på Hamar, har det ligget til grunn at dette må erstattes.

I tillegg er det for Sykehuset Innlandet HF krevende å oppnå god bruk av ressurser med høy kompetanse, fordi disse er spredt på ulike enheter med små fagmiljøer som er sårbare for mangel på nøkkelpersonell.

Målet med konseptfasen har vært å finne det konseptet som best støtter opp under målbildet for helseforetaket, jf. styresak 005-2019 *Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF*, innenfor rammene av det foretaksmøtet senere har vedtatt. Som orientert om i styresak 033-2025 *Sykehuset Innlandet HF - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, orientering om konseptfasen*, har konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF omfattet utredninger av et Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv, elektiv ortopedi og rehabilitering, akutt indremedisin, fødestue og barselavdeling ved sykehuset i Elverum, og en styrking av tilbudet ved sykehuset på Tynset. En luftambulansebase med døgntilgjengeliggjort vaktfunksjon i nærheten av Elverum er også inkludert i utredningen.

Konseptfasen har pågått siden 2021 og har blitt utviklet i flere omganger. Våren 2024 viste arbeidet med konseptfasens steg 2 en betydelig økning i areal og kostnader for Mjøssykehuset sammenlignet med estimatene fra steg 1. En omfattende gjennomgang av tredjepart og evaluering fasilitert av *Bedre megaprojekter* ble derfor igangsatt. Dette arbeidet har ført til en reduksjon i investeringsestimatet med omtrent 1,9 milliarder kroner, noe administrerende direktør anser som en betydelig forbedring.

Administrerende direktør mener at arbeidet i konseptfasen har resultert i et konsept som ivaretar de prosjektutløsende behovene og legger til rette for at Sykehuset Innlandet HF kan realisere målbildet vedtatt i foretaksmøte.

Den nye sykehusstrukturen vil bidra til et framtidsrettet tilbud til pasientene i Sykehuset Innlandet HF og legge til rette for helhetlig og god pasientbehandling.

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF har uttrykt sin klare støtte til den framtidige sykehusstruktur i Innlandet, og brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF har bekreftet sin støtte. Styringsgruppen for prosjektet har i sitt siste møte 10. mars anbefalt mot en stemme at konseptrapporten godkjennes.

En viktig del av avklaringsarbeidet i konseptfasen har vært å få bedre grunnlag for å vurdere kostnader til infrastruktur og rekkefølgekrav. Administrerende direktør har igjennom skriftlig dialog med Ringsaker kommune fått tilbakemelding på hvordan kommunen ser for seg ansvarsfordelingen for rekkefølgekrav i de videre utbyggingene i og rundt etableringen

av Mjøssykehuset. Selv om reguleringsarbeidet ikke er ferdigstilt, og det fortsatt kan komme høringsinnspill og eventuelle innsigelser som må tas hensyn til, vurderer administrerende direktør det som risikoreduserende at Ringsaker kommune har kommunisert sitt syn på dette i forkant av reguleringsbehandlingen. Administrerende direktør legger til grunn at ansvaret for finansieringen av rekkefølgekrav blir som beskrevet i brev fra Ringsaker kommune jf. styresak 033-2025, vedlegg 4, og vil holde styret løpet orientert om eventuelle endringer. Det er nødvendig med en forutsigbarhet for rekkefølgekrav og kostnadene ved disse, og søknaden om finansiering vil inkludere de kjente forholdene.

Administrerende direktør mener at videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil gi muligheter for faglig utvikling, men samtidig kreve stor omstillingsevne for helseforetaket. Den demografiske utviklingen for Innlandet, lokaliseringen av Mjøssykehuset og omstillingsprosessen helseforetaket må igjennom, er alle områder som vil påvirke evnen til å rekruttere helsepersonell i årene framover. Administrerende direktør mener at omstilling og rekruttering må ha særskilt oppmerksomhet fra Sykehuset Innlandet HF, og at det i det videre arbeidet prioriteres tiltak for å gjøre sykehuset til en foretrukket arbeidsplass.

Sykehuset Innlandet HF står ovenfor en betydelig økonomisk omstilling og krav til gevinstrealisering for å kunne betjene kapitalkostnadene fra ny sykehusstruktur og for å kunne gjøre nødvendige investeringer i øvrige bygg og medisinsk-teknisk utstyr. I tråd med gjeldende retningslinjer har helseforetaket utarbeidet en spesifisert gevinstoversikt, hvor forutsetningene for utvalgte, større gevinstområder er underbygget med relevante sammenligninger mot driften ved andre helseforetak i Helse Sør-Øst. I forprosjektet skal helseforetaket utarbeide en gevinstrealiseringsplan, som konkretiserer gevinstoversikten med fordeling av ansvar for gevinstrealiseringen på et operativt nivå ved helseforetaket. Administrerende direktør vurderer at foreliggende gevinstoversikt gir et godt grunnlag for videre detaljering i form av en gevinstrealiseringsplan i forprosjektfasen.

Sykehuset Innlandet HF har videre utarbeidet en plan for kostnadstilpasninger fram mot ny sykehusstruktur tas i bruk, som helseforetaket skal konkretisere ytterligere med tiltak innen større omstillinger i løpet av 2025. Administrerende direktør vurderer planen som krevende, men ser det som en styrke at utviklingen som ligger til grunn for vurderingene av økonomisk bæreevne, konservativt forutsetter at kun 50 prosent av de estimerte effektene fra kostnadstilpasninger skal realiseres. En vesentlig andel av kostnadstilpasningen skal realiseres i 2026 og 2027, og ved en framtidig beslutning om prosjektgjennomføring (B4-beslutning), tentativt medio 2027, vil det dermed foreligge ny informasjon som gir Helse Sør-Øst RHF grunnlag for å vurdere helseforetakets evne til å realisere den forutsatte bedringen i driftsmargin. Administrerende direktør anbefaler at styret ber om at Sykehuset Innlandet HFs arbeid med omstilling og økonomisk forbedring i forkant av innflytting styrkes. Videre at det skal gis en utvidet status for arbeidet i forbindelse med godkjenning av oppstart forprosjekt og ved investeringsbeslutning etter gjennomført forprosjekt.

Med bakgrunn i prosjektets iboende risiko og vurderinger fra ekstern kvalitetssikrer vurderer administrerende direktør at Helse Sør-Øst RHF bør søke om finansiering basert på 90 prosent av forventet prosjektkostnad (P50-estimat) for sykehusarealene, og 100 prosent av P85-estimat for universitetsarealene, i henhold til gjeldende retningslinjer, slik at prosjektet kan finansieres fra og med 2026.

Administrerende direktør anbefaler at styret ber om at intensjonsavtalene med universitetene ferdigstilles før oppstart av forprosjekt. Gjeldende retningslinjer for universitetsarealer i sykehusbyggprosjekter fra Prop. 1 S (2017-2018) legges til grunn. Omsøkt finansiering forutsetter investeringslån for 100 prosent av P85-estimat for universitetsarealene, og det forutsettes at universitetene betaler en kostnadsdekkende husleie.

Administrerende direktør vurderer at det er flere forhold ved videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF som taler for at deler av den statlige finansieringen bør kunne gis som investeringstilskudd. Prosjektets størrelse relativt til helseforetakets driftsinntekter og den relativt sett lavere framtidige forventede realveksten i driftsinntekter med bakgrunn i demografiske forhold, gjør prosjektet mer krevende økonomisk for Sykehuset Innlandet HF enn for andre helseforetak. Videre har foretaksmøtets vedtak om styrking av tilbudet ved Elverum og Tynset medført en mer krevende økonomisk situasjon for helseforetaket. Plasseringen av Mjøssykehuset på Moelv medfører forsterket fokus på tiltak for å understøtte rekruttering. Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil også bli et nytt megaprojekt i porteføljen til foretaksgruppen Helse Sør-Øst, med stor grad av samtidighet i prosjektgjennomføringen og gevinstuttaket med nye Aker og nye Rikshospitalet, noe som øker foretaksgruppens økonomiske risikobilde betydelig. Administrerende direktør anbefaler derfor at styret ber om at deler av finansieringen gis som et investeringstilskudd. Eventuelle rekkefølgekrav fra statlige myndigheter bør følges av en tilsvarende økning av investeringstilskuddet.

Helse Sør-Øst RHF har som mål å bygge Mjøssykehuset med best mulig kvalitet og bærekraft til lavest mulig kostnad. For å oppnå dette er det viktig å iverksette tiltak som kan redusere risikoen i gjennomføringen av byggeprosjektet. Det understrekes at byggingen av Mjøssykehuset er et megaprojekt, og at det må arbeides med særskilte tiltak for å redusere den medfølgende risikoen. Administrerende direktør anbefaler derfor at prosjektet planlegges med en gjennomføringsstrategi som minimerer risiko og legger til rette for kostnadseffektiv bygging gjennom gjenbruk av prosjekterte løsninger, standardisering og industrialisering.

Administrerende direktør vil spesifisere eierkravene til det videre arbeidet, som grunnlag for å anbefale styringsmål og mandat for forprosjekt. Det skal planlegges med relevant medvirkning fra ledere, ansatte og brukere ved Sykehuset Innlandet HF.

Administrerende direktør legger til grunn at oppstart forprosjekt forutsetter finansiering og styrets godkjenning, og anbefaler at økonomisk styringsmål og finansieringssammensetning fastsettes ved godkjenning av oppstart av forprosjektet. Administrerende direktør anbefaler at fremlagt konseptrapport godkjennes, og ber om at den legges til grunn for det videre arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF samt at det søkes om finansiering fra og med 2026 på dette grunnlaget.

Trykte vedlegg:

1. Styresak Sykehuset Innlandet HF 25. mars 2025 - sak 033-2025 Sykehuset Innlandet HF
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet – konseptfasen steg 2
2. Foreløpig protokoll styremøte i Sykehuset Innlandet HF 25. mars 2025
3. Styresak Sykehuset Innlandet HF 27. februar 2025 - sak 016-2025 *Videreutvikling av sykehuset Innlandet HF – orientering om arbeider i konseptfase steg 2*
4. Protokoll fra styremøte Sykehuset Innlandet HF 27. februar 2025
5. Styresak Sykehuset Innlandet HF 10. mars 2025 – sak 025-2025 *Økonomisk bæreevne i perioden 2026-2032*
6. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet HF 10.mars 2025
7. Brev fra Ringsaker kommune – Rekkefølgekrav datert 29. januar 2025

Utrykte vedlegg:

- [Konseptfaserapport videreutvikling Sykehuset Innlandet HF med vedlegg](#)